

Higiene de manos y observación de los cinco momentos

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Reducir transmisión por manos durante valoración, intervención, limpieza y manejo de dispositivos.

2. Alcance y condiciones de uso

Adaptación de los cinco momentos a fisioterapia ambulatoria: contacto del paciente y entorno, técnica limpia o aséptica y riesgo de fluidos.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Mantener manos libres de elementos que dificultan higiene y verificar disponibilidad de agua

Mantener manos libres de elementos que dificultan higiene y verificar disponibilidad de agua, jabón, secado y solución alcohólica apropiada. Registrar ausencia y gestionar reposición.

2. Realizar higiene antes de tocar al paciente y antes de una tarea limpia o aséptica; repeti

Realizar higiene antes de tocar al paciente y antes de una tarea limpia o aséptica; repetir después de riesgo de exposición a fluidos, después del contacto con paciente y después de su entorno.

3. Usar preparación alcohólica cuando sea apropiada; lavado con agua y jabón cuando hay sucie

Usar preparación alcohólica cuando sea apropiada; lavado con agua y jabón cuando hay suciedad visible y en situaciones que lo requieren. Como referencia OMS, fricción alcohólica 20-30 segundos y lavado 40-60 segundos, siguiendo producto y técnica.

4. Cubrir todas las superficies de manos, dedos, pulgares y puntas, secar cuando corresponde

Cubrir todas las superficies de manos, dedos, pulgares y puntas, secar cuando corresponde y evitar recontaminación. No tocar el teléfono después de higienizar y antes de atención sin repetir la higiene.

5. Colocar y retirar guantes de acuerdo con la tarea y realizar higiene antes y después

Colocar y retirar guantes de acuerdo con la tarea y realizar higiene antes y después. No limpiar o desinfectar guantes para reutilizarlos entre pacientes.

6. Observar oportunidades y acciones, registrar adherencia sin datos del paciente y retroalim

Observar oportunidades y acciones, registrar adherencia sin datos del paciente y retroalimentar al equipo. Usar el afiche como apoyo, junto con insumos y demostración de la práctica.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Momentos por oportunidad de atención, no solo por sesión.

Guantes no sustituyen manos.

Indicador: acciones correctas / oportunidades observadas x 100.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Fecha área y observador	
Momento u oportunidad	
Acción realizada	
Producto disponible	
Técnica observada	
Uso de guantes	
Barreras de acceso	
Retroalimentación	
Acción	
Reobservación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576